



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Obstetricia y Enfermería
Hilda Zoraida Baca Neglia

**FACULTAD DE OBSTETRICIA Y ENFERMERÍA
HILDA ZORAIDA BACA NEGLIA**

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

**CALIDAD EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN
USUARIAS DEL CENTRO DE SALUD “MANUEL BERTORINI JORDAN” SAN
MIGUEL - MARZO 2024**

PARA OPTAR

EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN OBSTETRICIA

PRESENTADO POR:

BRENDA DEL ROSARIO RAMIREZ ROJAS

ASESOR (A)

DRA. ZULEMA BUSTAMANTE PUENTE

LIMA, PERÚ

2024

ÍNDICE

	Págs.
Portada	i
Índice	ii
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	1
1.1 Descripción de la situación problemática	1
1.2 Formulación del problema.....	3
1.3 Objetivos de la investigación.....	4
1.4 Justificación de la investigación	5
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	7
2.1 Antecedentes de la investigación	7
2.2 Bases teóricas	10
2.3 Definición de términos básicos.....	21
CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES	23
3.1 Formulación de hipótesis principal y derivadas	23
3.2 Variables y definición operacional	23
CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA	26
4.1 Diseño metodológico.....	26
4.2 Diseño muestral	26
4.3 Técnica de recolección de datos	28
4.4 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información	29
4.5 Aspectos éticos.....	29
CRONOGRAMA	30
PRESUPUESTO.....	31
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	32
ANEXOS.....	40

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la situación problemática

La calidad de atención en los servicios de salud actualmente desempeña un papel importante en las entidades prestadoras de salud convirtiéndose en un derecho fundamental de las personas, tiene una definición variable, ya que intervienen diferentes factores. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la calidad de la atención como “el grado en que los servicios de salud para las personas y las poblaciones aumentan la probabilidad de resultados de salud deseados”¹.

Así mismo los servicios de salud de alta calidad engloban una correcta atención en el momento correcto y por consiguiente responda a las necesidades y preferencias de los usuarios del servicio, para así minimizar los daños y evitar desperdiciar recursos².

La OMS también define que los requisitos necesarios para alcanzar la calidad en salud son: alto nivel de excelencia profesional, uso eficiente de los recursos, mínimo riesgo para el paciente, alto grado de satisfacción del paciente y la valoración del impacto final en la salud³.

La calidad de los servicios de salud no solo depende de un grupo de personas y mucho menos es sinónimo de lujo o complejidad, por el contrario, involucra toda la institución

y debe ser de igual manera en todos los niveles de atención además que depende de todos⁴. Es importante que se garantice que la atención sea efectiva, segura y en consonancia con la preferencia y necesidades de las personas y comunidades, ya que las expectativas de los usuarios cambian con relación a su cultura, experiencias previas, grado de instrucción, entre otras variables, por consiguiente, la calidad de atención es fundamental para la cobertura sanitaria universal ^{2,4}.

Por otro lado, la planificación familiar es un derecho humano que se define como la decisión libre, voluntaria e informada de las personas para que puedan elegir el intervalo de tiempo y cuántos hijos desean tener. Así mismo puedan elegir qué métodos anticonceptivos (MAC) desean usar para planificar su familia. La calidad en el servicio de planificación familiar debe de asegurar que el usuario sea atendido como se merece al mismo tiempo de proporcionar un mejor servicio e información necesaria y correcta.

En México, se realizó un estudio sobre calidad de los servicios de planificación familiar en 6 estados de la República Mexicana, donde se incluyó 12 clínicas en entornos urbanos y rurales, los resultados indicaron diversos problemas que son preocupantes e inaceptables para acceder a un servicio de calidad. En sus hallazgos se pudo evidenciar que las usuarias atraviesan problemas con la escasez de métodos anticonceptivos, también reciben información inexacta y a menudo errónea, a pesar de que ninguna usuaria catalogó la atención como indiferente o irrespetuosa, si indicaron que en algunas experiencias el personal parecía haber inducido sus decisiones anticonceptivas⁵.

En Perú, se realizó un estudio sobre calidad de los servicios de planificación familiar en 2 centros de salud del Ministerio de Salud pertenecientes a la Región Junín en donde se evidenció claramente que no se cumplió con las expectativas de los usuarios ni se abordó las necesidades integrales de salud. Un 25% de las usuarias manifestó que el personal de salud normalmente está malhumorado, el 17% no es tratable, el 80% de las usuarias refieren no conocer sus derechos como usuarias⁶.

La baja calidad de la atención es uno de los mayores obstáculos para poder enfrentar los problemas sanitarios⁷. Por consiguiente, se debe de asegurar que el nivel de atención prestado en el servicio sea el adecuado y que cumpla con los atributos que caracterizan una buena atención de la salud y sus indicadores: oportunidad, eficacia, integralidad, accesibilidad, seguridad, respeto al usuario, información completa, trabajo en equipo, participación social, satisfacción del usuario externo y satisfacción del usuario interno⁸.

Por lo mencionado, es importante realizar la presente investigación cuyo objetivo será determinar el nivel de calidad en la atención del servicio de planificación familiar en usuarias del Centro de Salud “Manuel Bertorini Jordan” San Miguel y de esta forma conocer la calidad en la atención en esta institución.

1.2 Formulación del problema

- ¿Cuál es el nivel de calidad en la atención del servicio de Planificación Familiar en usuarias del Centro de Salud “Manuel Bertorini Jordan” San Miguel marzo 2024?

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo General:

- Determinar el nivel de calidad en la atención del servicio de Planificación Familiar en usuarias del Centro de Salud “Manuel Bertorini Jordan” San Miguel durante el mes de marzo 2024.

1.3.2 Objetivos Específicos:

- Identificar el grado de fiabilidad del servicio de Planificación Familiar en la atención a las usuarias en el Centro de Salud “Manuel Bertorini Jordan” San Miguel.
- Identificar el grado de capacidad de respuesta del servicio de Planificación Familiar en la atención a las usuarias en el Centro de Salud “Manuel Bertorini Jordan” San Miguel.
- Identificar el grado de seguridad del servicio de Planificación Familiar en la atención a las usuarias en el Centro de Salud “Manuel Bertorini Jordan” San Miguel.
- Identificar el grado de empatía del servicio de Planificación Familiar en la atención a las usuarias en el Centro de Salud “Manuel Bertorini Jordan” San Miguel.
- Identificar los elementos tangibles del servicio de Planificación Familiar en la atención a las usuarias en el Centro de Salud “Manuel Bertorini Jordan” San Miguel.

1.4 Justificación de la investigación

1.4.1 Importancia de la investigación

La calidad de atención en la actualidad es de suma importancia, ya que se ha convertido en uno de los pilares básicos de la atención en el servicio de planificación familiar, las personas hoy en día están más pendiente de sus derechos como usuarios y el cómo son tratados por parte de los profesionales de salud. Buscan una atención de calidad en donde todas sus necesidades sean atendidas, la información brindada sea correcta, haya una buena comunicación y el personal de salud le brinden seguridad al paciente en todo momento, un servicio sin carencias de recursos como son los métodos anticonceptivos, con buenas instalaciones y todos los insumos necesarios para cualquier procedimiento que se realice.

El propósito de la presente investigación es determinar el nivel de calidad en la atención del servicio de planificación familiar de dicha institución con el fin de poder identificar los posibles problemas o falencias así mismo identificar las posibles fortalezas del servicio, con los resultados se podrá comprender a los usuarios en lo que no están satisfechos y por consiguiente mejorar la atención y dar solución oportuna. Por otro lado, la presente investigación será de utilidad para los profesionales del servicio de planificación familiar y para los directivos del centro de salud, lo que les permitirá proponer mejoras y/o estrategias y así ofrecer un servicio de calidad considerando al usuario como un componente importante en el servicio.

1.4.2 Viabilidad del estudio

Esta investigación será viable debido a que se cuenta con el acceso al centro de salud, los directivos del Centro de Salud “Manuel Bertorini Jordan” San Miguel brindarán las facilidades y el apoyo necesario para realizar la investigación en dicho establecimiento. A nivel personal se cuenta con las herramientas intelectuales y el tiempo necesario que requiere la investigación. Así mismo el investigador cuenta con los recursos económicos para cubrir los gastos que requiere el proceso investigativo.

1.5 Limitaciones de estudio

Se podrían considerar como limitaciones que las usuarias no deseen participar en la realización de la investigación, así como la demora en los trámites administrativos que debe seguir el proyecto para su revisión y aprobación del comité de ética de la DIRIS Lima Centro.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

Geta T et al.⁹ en 2023, realizaron una investigación en el sur de Etiopía cuyo objetivo fue evaluar la calidad del asesoramiento anticonceptivo utilizando un modelo de calidad del servicio, su metodología de estudio fue transversal. En sus resultados se evidenció que todas las dimensiones de calidad del servicio tuvieron brechas negativas, la mayor brecha se evidenció en la dimensión fiabilidad (valor mediano = -3,25), la dimensión capacidad de respuesta (mediana = -2,52), la dimensión seguridad (mediana = -2,5), la dimensión empatía (mediana = -2,60), y por último la dimensión elementos tangibles fue la que tuvo una brecha pequeña (mediana = -1,75). En conclusión, los resultados demostraron que la calidad global del servicio fue baja, esto indicó que las expectativas de las usuarias encuestadas eran muy altas en comparación a la percepción que tuvieron.

Pires P et al.¹⁰ en 2022, realizaron una investigación en Mozambique el cual tuvo como objetivo evaluar la opinión de los usuarios sobre la calidad en sus visitas al servicio de planificación familiar del Centro de Salud Marrerre, su metodología de estudio fue cuantitativo, descriptivo, de corte transversal. En los resultados se pudo evidenciar algunas deficiencias importantes, el 51,8% considero que el profesional de salud nunca se presenta, el 40% manifestó que nunca pregunta si el usuario tiene alguna

duda, el 39,3% anima al usuario a hacer preguntas, el 43,6% explica lo que sucederá en la consulta, el 48,6% hace una retroalimentación de la información más importante al final de la consulta, el 1,4% indicó interrupciones en las consultas para hablar por teléfono. Se encontró que el personal de salud presenta deficiencias en la información y comunicación con los usuarios del servicio. En conclusión, la evaluación global de la calidad del servicio de planificación familiar muestra que la mayoría está satisfecha, el 90,9% estuvo satisfecho con el servicio, el 2,8% no opina y el 6,3% no estuvo satisfecho.

Kriel Y et al.¹¹ en 2021, realizaron una investigación en Sudáfrica, Zambia y Kenia cuyo objetivo fue explorar la calidad del servicio de planificación familiar y la anticoncepción. Su metodología de estudio fue cualitativa, exploratoria. Sus resultados fueron que los usuarios del servicio tenían una autonomía limitada para decidir el MAC que deseaban utilizar, ya que los profesionales de salud elegían por ellos, había una falta de profesional suficientemente capacitado para prestar el servicio, la infraestructura y la privacidad era inadecuada, lo cual limitaba la capacidad para prestar una atención de calidad, el profesional tenía actitudes y comportamientos negativos que provocan que los usuarios tengan miedo y como consecuencia se mostraban reacios a ir al servicio. También se encontró que había un asesoramiento e información insuficiente relacionada a la planificación familiar. Los tiempos de espera eran prolongados por el alto volumen de usuarios y el personal de salud era multitarea y como consecuencia había una reducción en el tiempo que se dedicaba a la consulta. En conclusión, la mayoría de los usuarios manifestaron que no se encontraban satisfechos con la calidad de atención prestada.

Thongmixay S et al.¹² en 2020, en su investigación el cual tuvo como objetivo evaluar la calidad de los servicios de planificación familiar en los centros sanitarios públicos de la República Democrática Popular Lao, su metodología de estudio fue transversal, descriptiva. Con los resultados se identificó que la información brindada durante las consultas y la información relacionada con los MAC fue insuficiente, nunca se hablaba en consulta sobre las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH/SIDA, la relación interpersonal entre el usuario y el profesional no era suficientemente buena. Una parte de las usuarias considero que no había privacidad en consulta porque consideraban que otras personas podían escucharlos u observar si es que se realizaba algún procedimiento. En conclusión, la mencionada investigación sugiere que se hagan intervenciones para mejorar la calidad de los servicios de planificación familiar para así garantizar el acceso de todas las mujeres en edad reproductiva.

Pastrana R et al.¹³ en 2020, realizaron una investigación en México, se seleccionó de manera aleatoria 10 a 17 establecimientos de salud, el objetivo de la investigación fue evaluar la calidad de los servicios de salud amigables para los adolescentes con base en las dimensiones de accesibilidad, oportunidad, aceptabilidad/adaptabilidad, seguridad y continuidad. Su metodología de estudio fue cualitativa, utilizaron la técnica de usuario simulado la cual es una forma de observación participante y oculta en donde se obtiene información desde la perspectiva del usuario. Sus resultados en la dimensión accesibilidad en general fueron favorable con fácil acceso a la ubicación, había señalización interna adecuada que permitió ubicar fácilmente el servicio, cuando no había señalización debían de pedir informes, pero las indicaciones no eran claras lo cual ocasionaba que hubiera demoras en la atención. En la dimensión oportunidad, el

tiempo de espera fue menos a 30 minutos en la mayoría, pero en una clínica se evidenció una espera de aproximadamente 4 horas, los usuarios simulados evidenciaron que el interrogatorio fue incompleto a la vez que se registraron prácticas inadecuadas de detección de conductas sexuales de riesgo. En la dimensión aceptabilidad/adaptabilidad, la privacidad fue vulnerada por la atención en sala de espera, atención simultánea de pacientes en el mismo consultorio, interrupciones y dejar la puerta abierta durante la consulta. En la dimensión seguridad el tema mejor explicado por parte del personal de salud fue los MAC y el menos explicado fue sobre las ITS/VIH. Por último, en la dimensión continuidad no se ofertó servicios adicionales, no se invitó a los usuarios a acudir a charlas sobre salud sexual y reproductiva. En conclusión, se reportaron hallazgos importantes de la calidad durante la atención, identificándose que no se brinda una atención integral, olvidándose de aspectos preventivos y la continuidad en la atención.

2.2 Bases teóricas

2.2.1 Historia de calidad

La calidad es un concepto arraigado a la esencia del ser humano que viene desde el mismo origen del hombre, este ha comprendido que el hacer las cosas bien y de la mejor manera posible le dará ventaja sobre los demás y en su entorno. Con la evolución el hombre ha debido de controlar la calidad de todo en su entorno como por ejemplo la calidad de los alimentos que consumía, aprendió a diferenciar entre los productos comestibles y los que no lo son. Al ellos mismo construir sus armas debían de cerciorarse que dichas armas sean de calidad para que cumplieran la función por las que fueron creadas. Con el paso del tiempo y la formación de las

civilizaciones el término de calidad fue más importante, las construcciones de las casas debían ser de calidad, tenemos de ejemplo a los fenicios, ellos utilizaban una acción correctiva para asegurar la calidad y así eliminar la repetición de errores, tomando la decisión de cortar la mano de la persona responsable de la calidad insatisfactoria¹⁴.

En la edad media surgen mercados en donde la calidad de los productos adquiere prestigio y se inicia la costumbre de poner marca a los productos para así generar una buena reputación. En el siglo XIII los aprendices y los gremios empezaron a existir, los artesanos se convirtieron en instructores de los oficios y a la vez hacían de inspectores, ya que quien más que ellos conocían su trabajo y así hacían que sus productos pasaran por un control de calidad y así satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes. Con la llegada de la era industrial las cosas cambiaron, la producción era masiva y realizadas por fábricas, con los altos niveles de demanda la calidad era distinta con los nuevos esquemas productivos haciéndolo así necesario mejorar la calidad, en consecuencia, la función de inspección se convirtió en un elemento fundamental haciendo que se identificara los productos que no se ajustaban a los estándares deseados y por consiguiente no llegaran a las manos de los clientes¹⁴.

A finales del siglo XIX en los Estados Unidos desapareció la comunicación que había entre los clientes y los fabricantes tras la aparición de la producción en serie, dando inicio a una estandarización de las condiciones y métodos de trabajo, dando como consecuencia una baja en la calidad de los productos, ya que no eran

inspeccionados por cada operario como solían hacerlo. Como solución se adoptó la creación de la inspección en la fábrica apareciendo así los departamentos de calidad, lo que hace este departamento es inspeccionar que el producto final no tenga defectos y en caso haberlos poder corregirlos para así evitar que le llegue al consumidor un producto de calidad insatisfecha, con el fin de la primera guerra mundial la producción en serie se va mejorando dando inicio a la etapa del desarrollo del concepto de calidad en donde la inspección se convierte en una herramienta de la calidad¹⁴.

Posteriormente, aparece el término de proceso de calidad total que es un esfuerzo para alcanzar la calidad en distintos aspectos de las organizaciones sin importar su actividad económica tales como las áreas de finanzas, ventas, personal, mantenimientos, administración, manufactura y servicios¹⁴.

2.2.2 Concepto de calidad

El concepto de calidad es relativo al uso esperado y al cliente debido que varía mucho según sea el producto, servicio y tipo de empresa en donde se desarrolle¹⁵. Etimológicamente el termino calidad proviene del latín *qualitatem* el cual su significado expresa un atributo o propiedad que distingue a las personas o cosas, también puede venir del griego *kalós* el cual su significado es lo que funciona bien, lo bello, lo apto, lo favorable, lo hermoso, lo noble¹⁶. Una definición más clara es que la calidad son los rasgos y características de un producto o servicio que tiene como finalidad satisfacer las necesidades y expectativas del cliente o usuario y así

cumplir con las especificaciones para lo que fue diseñado. La calidad debe ser considerado desde el punto de vista del usuario para así realzar el servicio o producto que es ofertado¹⁵.

2.2.3 Calidad en salud

La calidad ha sido un tema muy tratado en el transcurso de los años y cada vez ha ganado mayor importancia en el área de la salud, como ya es mencionado su definición es variable y de carácter objetivo y subjetivo debido a los múltiples factores involucrados¹⁷. Su definición también ha ido evolucionando con el pasar del tiempo, antiguamente se limitaba en la relación médico- paciente, pero ahora abarca más que eso con los sistemas y servicios¹⁶. Donabedian define a la calidad en salud como la capacidad que tienen los servicios para proporcionar mayores beneficios reduciendo los riesgos para los usuarios en base a los recursos disponibles y los valores sociales imperantes¹⁸.

Para que los servicios se consideren de calidad deben de ser:

- Eficaces para proporcionar un servicio en base a evidencias y a quienes lo necesitan¹⁹.
- Seguros para evitar daños en las personas a quien el cuidado está destinado¹⁹.
- Centrado en las personas para proporcionar atención que responda según las preferencias, necesidades y valores personales¹⁹.
- Oportunos para que haya una reducción en el tiempo de espera y evitar demoras y así prevenir posibles complicaciones que pueden ser perjudiciales¹⁹.

- Equitativo para así proporcionar una atención de calidad independientemente del género, edad, raza, idioma, ubicación geográfica, religión, situación socioeconómica, afiliación política, etc¹⁹.
- Integrados para proporcionar una atención en donde se disponga toda la gama de servicios de salud y coordinada en todos los niveles¹⁹.
- Eficientes para maximizar el beneficio de todos los recursos disponibles y evitar su desperdicio¹⁹.

Un servicio de salud de buena calidad no solo implica ofrecer un buen trato a los pacientes o tener buenas intenciones, sino que es mucho más que eso incluyendo un personal cualificado y competente, una buena gobernanza, recursos financieros que permitan la atención, medicamentos, dispositivos y tecnologías disponibles que sean seguros y regulados, instalaciones accesibles y correctamente equipados para así lograr una cobertura universal de salud¹⁹. La calidad de los servicios de salud debe de ser evaluada constantemente para poder asegurar que el nivel del servicio prestado cumpla con todos los requisitos de excelencia que están establecidos y demandados por los usuarios y así prevalezca durante mucho tiempo¹⁶.

El objetivo de la calidad en los servicios de salud es de lograr una atención que sea segura y confiable. Se refiere por segura a que el usuario debe de recibir una atención en donde sea libre de errores y a su vez se logre restablecer la salud en la medida de lo posible evitando que la atención recibida tenga como consecuencia lesiones colaterales. Se refiere por confiable a que tanto los pacientes como sus

familiares confíen en la labor de los profesionales. La seguridad es una de las dimensiones claves de la calidad convirtiéndose en un objetivo importante para la gestión de la calidad en los sistemas de salud¹⁶.

2.2.4 Medición de calidad

2.2.4.1 Modelo SERVQUAL

En 1985 Parasuraman, Zeithmal y Berry diseñaron un modelo teórico de calidad del servicio, dicho modelo presento 10 dimensiones de evaluación y es conocido como modelo gaps o modelo de brechas, este modelo describe la calidad como la diferencia entre la expectativa y la percepción del servicio brindado. Con el pasar del tiempo este modelo fue modificado reduciendo de 10 dimensiones a solo 5 dimensiones¹⁵. Estas dimensiones son: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles²⁰.

Dicha reducción de dimensiones paso siendo a lo que conocemos hoy en día como el modelo SERVQUAL que se diseñó en 1988 con el auspicio del Marketing Science Institute. El propósito de dicha escala multidimensional es medir y relacionar la calidad de los servicios a partir de las expectativas y las percepciones de los usuarios acerca del servicio prestado. Las dimensiones creadas en este modelo fueron hechas de manera genérica lo que quiere decir que pueden ser utilizadas en cualquier organización y son utilizadas en un tiempo específico²¹. El modelo SERVQUAL fue validado en Latinoamérica en 1992 por

primera vez por Michelsen Consulting y el Instituto Latinoamericano de Calidad en los servicios²².

La expectativa del usuario o cliente se define como es que la persona espera que sea el servicio, esto va a estar relacionado también a sus experiencias previas, cultura, comunicación de boca a boca y otro tipo de información que tenga el usuario. La percepción se define como es que el usuario valora lo que recibe. Las brechas que existan entre estas 2 variables es la medición de la calidad según el modelo SERVQUAL²³.

El modelo SERVQUAL es en base a un cuestionario estructurado que es aplicado directamente a los usuarios, y puede ser adaptado según a la organización donde se aplique y las necesidades de medición, consta de preguntas cerradas que aborda las 5 dimensiones y tiene 22 declaraciones o ítems que busca recolectar las expectativas de un excelente servicio y las percepciones de los usuarios del servicio recibido^{15,21}. Se maneja una escala de Likert para determinar la importancia de cada ítem del cuestionario, en donde 1 equivale al puntaje más bajo que quiere decir que el usuario está en total desacuerdo y 7 equivale al puntaje más alto que quiere decir que el usuario está muy de acuerdo²⁰. Por su validez y confiabilidad esta herramienta multidimensional es la más aceptada y utilizada para medir la calidad del servicio¹⁷.

2.2.4.2 Dimensiones del Modelo SERVQUAL

a) Fiabilidad: Habilidad para realizar el servicio que se propone de modo cuidadoso, confiable y preciso²⁰.

- b) Capacidad de respuesta:** Disposición y voluntad de atender las necesidades de los usuarios y proporcionar un servicio rápido y oportuno²⁰.
- c) Seguridad:** Conocimientos y cortesía mostrado por los servidores/as y su habilidad para concitar credibilidad y confianza sobre lo que están realizando²⁰.
- d) Empatía:** Atención personalizada, capacidad de percibir y comprender los requerimientos de los usuarios²⁰.
- e) Elementos tangibles:** Apariencia y condiciones de las instalaciones físicas, equipos, infraestructura, materiales y personal²⁰.

2.2.4.3 Ventajas del Modelo SERVQUAL

Tiene la ventaja que es de fácil adaptación y puede ser modificado de acuerdo a las características de la organización a evaluar. Es útil para examinar la diversidad de opiniones de los usuarios o clientes¹⁵.

2.2.4.4 Desventajas del Modelo SERVQUAL

Las personas podrían no entender la dinámica del cuestionario y por consecuencia no saber con certeza el significado de las preguntas. Puede llegar también a ser un poco tedioso por el número de preguntas en su totalidad porque este cuestionario cuenta con 5 dimensiones a evaluar y 22 ítems o preguntas¹⁵.

2.2.4.5 SERVQUAL Modificado

Es una adaptación del modelo original realizado por el Ministerio de Salud con pequeñas modificaciones tanto en el modelo como en el contenido del cuestionario para evaluar la calidad de atención en los servicios de salud considerando las características de este sector²⁴.

2.2.5 Servicio de planificación familiar

Los servicios de planificación familiar son de suma importancia para garantizar una conducta sexual plena y permitir que los usuarios tomen decisiones libres e informadas con respecto a su reproducción en relación con su autonomía, dignidad y plan de vida, sin ningún tipo de discriminación o violencia, dichos servicios deberán estar conforme a estándares de disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y calidad para así adaptarse a las necesidades y expectativas de los usuarios del servicio²⁵. Deben de ser ofrecidos de manera gratuita en todos los establecimientos públicos de salud y en todos los niveles de atención, incluyendo la historia clínica, orientación/consejería y proporcionar los MAC²⁶.

Se entiende por derechos sexuales a que toda pareja o persona tenga una vida sexual responsable, satisfactoria y segura, libre de enfermedades, lesiones o violencia independientemente de su situación reproductiva. Tener una educación en sexualidad de carácter oportuno, integral, gradual, científica, con enfoque de género y respetando su orientación sexual. Contando con información, servicios de prevención y tratamiento para las ITS, VIH/SIDA²⁷.

Se entiende por derechos reproductivos a que toda pareja o persona pueda decidir libremente y responsablemente el número, periodo intergenésico y oportunidad de tener hijos, contando con información y medios de hacerlo. Acceder a los MAC para regular la fecundidad, contar con servicios de calidad para el control de las gestantes y atención de emergencias contando con todos los insumos y materiales necesarios para garantizar una maternidad segura y saludable²⁷.

2.2.5.1 Derechos de los usuarios en el servicio de planificación familiar

- a) Derecho a la privacidad: Durante consulta el caso a tratar sea de manera discreta, instalaciones con privacidad, en caso de procedimientos el usuario debe de usar bata, nunca estar desnudo/a²⁶.
- b) Derecho a la información: Información completa, comprensible, oportuna, adecuada y de fácil entendimiento²⁶.
- c) Derecho a conocer la identidad de las personas proveedoras del servicio: Conocer el nombre y el cargo del profesional de salud desde el inicio de la atención²⁶.
- d) Derecho a la seguridad personal: Atención segura, condiciones de bioseguridad, prácticas adecuadas cumpliendo con los estándares sanitarios²⁶.
- e) Derecho a la comunicación: Una comunicación de manera verbal o escrita como prefiera el usuario/a durante la atención²⁶.
- f) Derecho a la toma de decisiones: El usuario es libre de tomar decisiones con relación a su salud habiendo previamente identificado sus necesidades²⁶.
- g) Derecho a contar con una atención adecuada: El usuario podrá negarse a someterse a algún procedimiento o elección de método anticonceptivo aun habiendo recibido la información completa del mismo²⁶.
- h) Derecho al respeto y dignidad: No ser discriminado, recibir trato respetuoso, y respetar sus creencias, valores, conocimientos, actitudes, etc²⁶.
- i) Derecho al reclamo y resarcimiento: Expresar su malestar o disconformidad con el trato recibido o ser resarcido de ser el caso²⁶.

2.2.5.2 Atención en los servicios de planificación familiar

Para que los servicios de planificación familiar sean de calidad se debe de seguir un modelo de 5 pasos para así facilitar la orientación y consejería que se brindara al momento de la consulta²⁶.

- Paso 1: Establecer una relación cordial²⁶.
- Paso 2: Identificar las necesidades del usuario/a²⁶.
- Paso 3: Responder las necesidades del usuario/a²⁶.
- Paso 4: Verificar la comprensión del usuario/a²⁶.
- Paso 5: Mantener la relación cordial²⁶.

Al inicio de la consulta se debe de generar un trato cordial y respetuoso hacia el usuario/a manteniéndolo en todo momento, siempre considerando las creencias y costumbres de los/as usuarios/as y de la zona geográfica en donde se encuentran, el consultorio debe ser un ambiente acogedor, donde haya la privacidad y confidencialidad, en donde se cuente con todos los insumos necesarios y equipos en buen estado. Considerando el motivo de consulta, se debe de realizar una anamnesis adecuada y correcta realizando preguntas generales, averiguando los antecedentes personales, patológicos, obstétricos y familiares del usuario para así identificar sus necesidades o riesgos, se debe también de realizar un tamizaje de violencia de género. Es de suma importancia realizar un examen físico general incluyendo examen de mama, toma de Papanicolau en caso la usuaria no se lo haya realizado y tamizaje de prueba rápida de VIH²⁸. En caso de que la consulta sea por elección de método anticonceptivo, ya habiendo evaluado a la usuaria e identificado sus

necesidades, se deberá de seleccionar el método que más se acomode a la paciente, considerando la libre elección del usuario y los efectos secundarios del método, garantizando que no afecte su salud. La aplicación o entrega de método se deberá de proveer en el mismo consultorio y se procederá con el registro en la historia clínica y en los formatos correspondientes, en caso la usuaria sea nueva en el servicio debe de realizar una consejería/ orientación adecuada y completa respondiendo todas las dudas y preguntas de la paciente, así mismo verificar su entendimiento y la comprensión²⁶.

2.3 Definición de términos básicos

- Calidad en salud: Son los niveles de excelencia que caracterizan el servicio de salud o la atención de salud prestada con base en estándares de calidad aceptados²⁹.
- Servicio de planificación familiar: Servicio de atención médica diseñado para ayudar a las personas a planificar el tamaño de la familia. Se pueden utilizar varios métodos anticonceptivos para controlar el número y el momento de los partos³⁰.
- Paciente: Personas que participan en el sistema de atención médica con el propósito de recibir procedimientos terapéuticos, diagnósticos o preventivos³¹.
- Personal de salud: Personas que trabajan en la prestación de servicios de salud, ya sea como profesionales individuales o empleados de instituciones y programas de salud³².
- Derechos sexuales y reproductivos: Se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el

número, el espaciamiento y el momento de tener hijos y a disponer de la información y los medios para hacerlo, así como el derecho a alcanzar el más alto nivel de salud sexual y reproductiva³³.

CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1 Formulación de hipótesis principal y derivadas

Al ser un estudio descriptivo no requiere un planteamiento de hipótesis.

3.2 Variables y definición operacional

3.2.1 Variable

V1: Calidad en la atención

Variables	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición
Calidad de Atención	Será medido a través de un cuestionario estructurado en donde se utiliza el modelo SERVQUAL modificado, que consta de 22 ítems para evaluar la calidad en la atención de las usuarias del servicio de Planificación Familiar a partir de sus expectativas y percepciones.	Fiabilidad	1. Orientación adecuada para llegar al consultorio. 2. Atención en el horario programado. 3. Respeto por el orden de llegada para recibir la atención. 4. Historia clínica disponible. 5. Horario de atención conveniente.	Nominal
		Capacidad de respuesta	6. Tiempo de espera adecuado para la atención. 7. Desenvolvimiento eficiente del profesional en la atención. 8. Tiempo adecuado durante la atención en consultorio. 9. Rápida entrega del método anticonceptivo.	
		Seguridad	10. Privacidad durante su atención. 11. Profesional conoce los métodos de planificación familiar disponibles. 12. Profesional emplea palabras y material adecuado para entenderse. 13. Sensación de confidencialidad durante la atención.	
		Empatía	14. Trato con amabilidad, respeto y paciencia. 15. Lenguaje comprensible en su atención. 16. Suficiente información sobre la elección del método anticonceptivo. 17. Repitió información brindada asegurando la comprensión. 18. Información sobre las próximas citas a acudir.	

		Elementos tangibles	19. Buena señalización facilitando ubicación del consultorio. 20. Profesional Obstetras suficiente para informar y orientar a usuarias. 21. Suficientes métodos anticonceptivos necesarios para su atención. 22. Consultorio y sala de espera limpia y cómoda.	
--	--	---------------------	--	--

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA

4.1 Diseño metodológico

Este estudio tendrá un enfoque cuantitativo.

El diseño a utilizar será de tipo observacional, transversal, descriptivo y prospectivo.

4.2 Diseño muestral

Población:

La población de estudio estará conformada por todas las usuarias del servicio de planificación familiar atendidas en el Centro de Salud “Manuel Bertorini Jordan” San Miguel, que según datos del último semestre 2023, brindados por la Oficina de Estadística del establecimiento fueron un promedio 160 pacientes que se atienden de manera mensual en este consultorio.

Muestra:

Para el cálculo del tamaño muestral utilizaremos la fórmula para la estimación de una proporción en una población finita, cuando la variable principal es de tipo cualitativo:

$$n = \frac{Z_{\alpha/2}^2 * p * q * N}{(N - 1) E^2 + Z_{\alpha/2}^2 * p * q}$$

Donde:

- N= Total de la población
- $Z_{\alpha/2}^2 = 1.96^2$ (ya que la seguridad es del 95%)
- $p = 50\%$ proporción esperada ($p=0.50$)
- $q = 1 - p$ (en este caso es $1 - 0.50 = 0.50$)
- E = error absoluto (en este caso deseamos un 5%)

Reemplazando los datos en la fórmula:

$$n = \frac{Z_{\alpha/2}^2 * p * q * N}{(N - 1) E^2 + Z_{\alpha/2}^2 * p * q}$$

$$n = \frac{(1.96)^2 * 0.50 * 0.50 * 160}{(159) (0.05)^2 + (1.96)^2 * 0.50 * 0.50}$$

$$n = \frac{153.66}{1.35}$$

$$n = 113.82$$

Redondeando: $n = 114$

Criterios de inclusión:

- Usuarías mayores de 18 años.
- Usuarías continuadoras en el servicio.
- Usuarías que acepten voluntariamente y firmen el consentimiento informado para participar del estudio.
- Usuarías con una buena salud mental.

Criterios de exclusión:

- Usuarías pertenecientes a servicios diferentes a planificación familiar.
- Usuarías que al momento de realizar la encuesta desistan de participar del estudio.

4.3 Técnica de recolección de datos

Para la recolección de la información se utilizará un cuestionario de calidad en la atención del servicio de planificación familiar (SERVQUAL modificado) (ver Anexo 1) el cual fue adaptado, modificado y utilizado anteriormente por la autora Cupe L³⁴ quien hizo posible la validación del instrumento por 6 expertos (ver Anexo 3) así mismo la autora realizó una prueba piloto de dicho instrumento en donde se estableció que el instrumento es confiable para su aplicación, será aplicado de manera anónima a las usuarias según criterios de inclusión previa firma del consentimiento informado dando su aceptación de participar en el estudio, para tal fin se acudirá al establecimiento de salud de forma diaria en horario de atención de consulta de planificación familiar, una vez que la DIRIS Lima Centro haya dado la aprobación para la ejecución del proyecto.

4.4 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información

Una vez concluida la recolección de la información se procederá a codificar cada uno de los cuestionarios en orden ascendente, posteriormente se construirá una base de datos con ayuda del programa estadístico SPSS v25 donde se ingresarán cada uno de los cuestionarios codificados.

Una vez concluida esta etapa se procederá a calcular las frecuencias absolutas, relativas y medidas de tendencia central de las variables de estudio, los resultados serán organizados en tablas de doble entrada según los objetivos de estudio.

4.5 Aspectos éticos

Para la elaboración de la presente investigación se consideró los principios de la ética médica.

- Principio de autonomía: Relacionado con el consentimiento informado, se respetará al usuario en la toma de decisiones y en la libre participación de la investigación.
- Principio de beneficencia: La investigación tendrá beneficio para los usuarios del servicio de planificación familiar mejorando la calidad en la atención brindada.
- Principio de no maleficencia: No habrá ningún daño físico o psicológico hacia las participantes al participar en la presente investigación.
- Principio de justicia: Se respetará y amparará de manera justa todos los derechos de las participantes, la información obtenida será de absoluta y estricta reserva para el fin de la investigación así mismo manteniendo el anonimato de las participantes.

CRONOGRAMA

N°	Actividades	Meses					
		Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril
1	Identificación y formulación del problema	X					
2	Revisión de las fuentes de información	X					
3	Redacción de objetivos y operacionalización de las variables	X					
4	Determinación del diseño de investigación		X				
5	Determinación del marco muestral			X			
6	Selección de los estadígrafos a utilizar				X		
7	Recolección de datos					X	
8	Organización y procesamiento de los datos					X	
9	Análisis e interpretación de los resultados					X	X
10	Redacción del informe						X
11	Presentación del informe						X

PRESUPUESTO

Tipo	Servicios	Unidad	Costo unidad	Monto total
Recursos humanos	Investigador			
	Personal para la tabulación	3 horas	15	45.00
	Análisis estadístico			100.00
	Traducción del documento en ingles	15 hojas	10	150.00
	Sub total			
Adquisición de bienes	Material de escritorio (hojas, tóner de impresión, lapicero)			100.00
	Incentivo para participantes	20	10	200.00
	Sub total			
Servicios	Internet			30.00
	Impresión de cuestionarios y fotocopia de documentos			120.00
	Movilidad			100.00
	Sub total			
Total general				845.00

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Organización Mundial de la Salud [Internet]. Ginebra: OMS; c2023 [citado 16 de noviembre de 2023]. Disponible de: Servicios sanitarios de calidad (who.int)
2. Organización Mundial de la Salud, ODCE, Banco Mundial. Prestación de servicios de salud de calidad: un imperativo global para la cobertura sanitaria universal [Internet]. Ginebra; 2020 [citado 16 de noviembre 2023]. 108 p. Disponible de: *9789240016033-spa.pdf (who.int)
3. Asociación Médica Argentina. Código de Ética para el Equipo de Salud [Internet]. 3^a ed. Mendoza: Universidad del Aconcagua; 2016 [citado 19 de noviembre 2023]. 239 p. Disponible de: *CODIGO DE ETICA 3ra Edición.pdf (ama-med.org.ar)
4. Niño de Guzmán J. Mejorando la Calidad en los Servicios de Salud: Guía de acompañamiento [Internet]. Lima: SINCO Editores; 2005 [citado 20 de noviembre 2023]. Disponible de: *Mejorando_la_calidad_en_los_servicios_de_salud__Guía_de_acompañamiento20191017-26355-7adfs8.pdf (www.gob.pe)

5. Torres B, Heredia I, Ibáñez M, Ávila L. Quality of family services in Mexico: The perspective of demand. PLoS One [Internet]. 2019 [citado 20 de noviembre 2023]; 14(1). Disponible de: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210319>
6. Casallo S, Pérez G, Scarsi R. Calidad de atención en salud reproductiva y planificación familiar con enfoque de género e interculturalidad en los establecimientos de Salud de Chupaca y justicia, paz y vida – 2008. Prospect. Univ [Internet]. 2009 [citado 21 de noviembre 2023]; 06 (01-02): 13-19. Disponible de: vista de Calidad de atención en salud reproductiva y planificación familiar con enfoque de género e interculturalidad en los establecimientos de salud de chupaca y justicia, paz y vida – 2008 (uncp.edu.pe)
7. Perú. Ministerio de Salud. Documento Técnico: Política Nacional de Calidad en Salud [Internet]. Resolución Ministerial N° 727-2009/MINSA (2009 Oct 9) [citado 21 de noviembre 2023] Disponible de: politica nacional de calidad PDF (www.gob.pe)
8. Ministerio de Salud [Internet]. Lima: MINSA; c2002. Estándares de Calidad para el Primer Nivel de Atención en Salud; julio 2022 [citado 21 de noviembre 2023] Disponible de: Microsoft Word - Estándares .doc (www.gob.pe)
9. Geta Hardido T, Toru T, Ataro BA, Saol T. Evaluating quality of contraceptive counseling using SERVQUAL model: A cross-sectional study in southern

- Ethiopia, 2021. Women's Health [Internet]. 2023 [citado 28 de noviembre 2023];19. Disponible de: <https://doi.org/10.1177/17455057231185407>
10. Pires P, Mupueleque M, Macaringue C, Zakus D, Siemens R, Belo C. Users' perspectives on the quality of family planning services in Mozambique: a case study. *Pan Afr Med J* [Internet]. 2022 [citado 29 de noviembre 2023]; 4(42): 174. Disponible de: doi: 10.11604/pamj.2022.42.174.26049
11. Kriel Y, Milford C, Cordero JP, Suleman F, Petrus S. S, Smit JA. Quality of care in public sector family planning services in KwaZulu-Natal, South Africa: a qualitative evaluation from community and health care provider perspectives. *BMC Health Serv Res* [Internet]. 2021 [citado 30 de noviembre 2023]; 21: 1-16. Disponible de: <https://doi.org/10.1186/s12913-021-07247-w>
12. Thongmixay S, Schöneveld T, Vongxay V, Broerse J, Sychareun V, Essink D. Quality of family planning services for women of reproductive age in Lao PDR. *Glob Health Action* [Internet]. 2020 [citado 28 de noviembre 2023]; 13(sup2) Disponible de: doi: 10.1080 /16549716.2020.1788261
13. Pastrana R, Heredia I, Olvera M, Ibañez M, De Castro F, Villalobos A, Torres MP. Adolescent Friendly Services: quality assessment with simulated users. *Rev Saude Publica* [Internet]. 2020 [citado 30 de noviembre 2023]; 54: 36. Disponible de: <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2020054001812>

14. Cubillos M, Rozo D. El concepto de calidad: Historia, evolución e importancia para la competitividad. Rev Uni de La Salle [Internet]. 2009 [citado 03 de diciembre 2023]; (48): 80-99. Disponible de: *El concepto de calidad: Historia, evolución e importancia para la competitividad (lasalle.edu.co)
15. Bustamante M, Zerda E, Obando F, Tello M. Fundamentos de la calidad del servicio, el modelo SERVQUAL. Rev Empresarial [Internet]. 2019 [citado 03 de diciembre 2023]; 13 (2): 1-15. Disponible de: <https://doi.org/10.23878/empr.v13i2.159>
16. George R, Gámez Y, Matos D, González I, Labori R. Aspectos fundamentales de la calidad en los servicios de salud. Infodir [Internet]. 2022 [citado 07 de diciembre 2023]; (37): e1112. Disponible de: Aspectos fundamentales de la calidad en los servicios de salud (sld.cu)
17. Cabello E, Chirinos J. Validación y aplicación de encuestas SERVQUAL modificadas para medir la satisfacción de usuarios externos en servicios de salud. Rev Med Hered [Internet]. 2012 [citado 03 de diciembre 2023]; 23(2): 88-95. Disponible de: *v23n2ao2.pdf (scielo.org.pe)
18. Febres R, Mercado M. Patient satisfaction and quality of care of the internal medicine service of Hospital Daniel Alcides Carrión Huancayo- Perú. Rev Fac

- Med Hum [Internet]. 2020 [citado 05 de diciembre 2023]; 20 (3): 397-403.
Disponible de: <http://dx.doi.org/10.25176/rfmh.v20i3.3123>
19. Organización Mundial de la Salud [Internet]. Ginebra: OMS; c2023 [citado 07 de diciembre 2023]. Disponible de: Calidad de la atención (who.int)
20. Matsumoto R. Desarrollo del Modelo Servqual para la medición de la calidad del servicio en la empresa de publicidad Ayuda Experto. Rev Perspectivas [Internet]. 2014 [citado 03 de diciembre 2023]; (6): 181-209. Disponible de: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1994-37332014000200005
21. Ganga F, Alarcón N, Pedraja L. Medición de calidad de servicio mediante el modelo SERVQUAL: el caso del Juzgado de Garantía de la ciudad de Puerto Montt- Chile. Ingeniare. Rev. Chil. Ing [Internet]. 2019 [citado 03 de diciembre 2023]; 27 (4): 668-681. Disponible de: <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-33052019000400668>
22. Numpaque A, Rocha A. Modelos SERVQUAL y SERVQHOS para la evaluación de calidad de los servicios de salud. Rev. Fac. Med [Internet]. 2016 [citado 03 de diciembre 2023]; 64 (4): 715- 720. Disponible de: (PDF) Modelos SERVQUAL y SERVQHOS para la evaluación de calidad de los servicios de salud (researchgate.net)

23. Castillo E. Escala SERVQUAL para medir la calidad en el servicio [Internet]. C2010 [citado 03 de diciembre 2023]. Disponible de: Escala SERVQUAL para medir la calidad en el servicio • gestiopolis
24. Perú. Ministerio de Salud. Guía Técnica para la Evaluación de la Satisfacción del Usuario Externo en los Establecimientos y Servicios Médicos de Apoyo [Internet]. Resolución Ministerial N° 527-2011/MINSA (2011 Sep 11) [citado 03 de diciembre 2023] Disponible de: *Guía_técnica_para_la_evaluación_de_la_satisfacción_del_usuario_externo_en_los_establecimientos_y_servicios_médicos_de_apoyo__R.M._Nº_527-2011MINSA20191017-26355-1mq8r4m.pdf (www.gob.pe)
25. Defensoría del Pueblo. Supervisión de planificación familiar en las regiones de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Huancavelica, Junín, Ica, Loreto, Pasco y Puno [Internet]. Perú: Defensoría del Pueblo; 2023 [citado 10 de diciembre 2023]. Informe Defensorial N° 0002-2023-DP/ADM. Disponible de: *SUPERVISIÓN-DEFENSORIAL-A-LOS-SERVICIOS-DE-PANIFICACIÓN-FAMILIAR_Final.pdf
26. Perú. Ministerio de Salud. Norma técnica de salud de planificación familiar [Internet]. N° 2017-12663 (2017 Oct) [citado 10 de diciembre 2023]. Disponible de: *4191.pdf (minsa.gob.pe)

27. Guevara E. Derechos sexuales y derechos reproductivos. Rev Peru Investig Matern Perinat [Internet]. 2020 [citado 10 de diciembre 2023]; 9(1): 7-8. Disponible de: <https://doi.org/10.33421/inmp.2020183>
28. Ministerio de Salud. Guías nacionales de atención integral de la salud sexual y reproductiva [Internet]. Perú; 2004 [citado 11 de diciembre 2023]. 273p. Disponible de: MINISTERIO PARTE-1f modi (www.gob.pe)
29. National Library of Medicine [Internet]. Estados Unidos: NIH; c2023. Quality of Health Care [citado 14 de diciembre 2023]; [1 pantalla]. Disponible de: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/?term=Quality+of+Health+Care>
30. National Library of Medicine [Internet]. Estados Unidos: NIH; c2023. Family Planning Services [citado 14 de diciembre 2023]; [1 pantalla]. Disponible de: Family Planning Services - MeSH - NCBI (nih.gov)
31. National Library of Medicine [Internet]. Estados Unidos: NIH; c2023. Patients [citado 14 de diciembre 2023]; [1 pantalla]. Disponible de: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68010361>
32. National Library of Medicine [Internet]. Estados Unidos: NIH; c2023. Health Personnel [citado 14 de diciembre 2023]; [1 pantalla]. Disponible de: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68006282>

33. National Library of Medicine [Internet]. Estados Unidos: NIH; c2023. Reproductive Rights [citado 14 de diciembre 2023]; [1 pantalla]. Disponible de: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/?term=Reproductive+Rights>

34. Cupe L. Percepción de la calidad de atención en planificación familiar de las adolescentes con reincidencia de embarazo en el Hospital San Juan de Lurigancho setiembre- diciembre 2014 [tesis de pregrado en internet]. Perú: Universidad Nacional Mayor De San Marcos, 2015 [citado 12 de enero de 2024].
48 p. Disponible de:
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/4213/Cupe_ml.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ANEXOS

Anexo N°1: INSTRUMENTO- CUESTIONARIO

CALIDAD EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DEL CENTRO DE SALUD “MANUEL BERTORINI JORDAN” SAN MIGUEL

Fecha: ____/____/____

N° Encuesta: _____

Hora Inicio: _____

Hora Fin: _____

Estimado usuario (a), estamos interesados en conocer su opinión sobre la calidad de atención del servicio de planificación familiar del establecimiento de salud. Sus respuestas son totalmente confidenciales. Agradecemos su participación.

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO:

1. Edad en años: _____

2. Grado de instrucción:

Primaria ()

Secundaria ()

Superior Técnico ()

Superior Universitario ()

3. Ocupación:

Ama de casa ()

Estudiante ()

Trabaja ()

4. Estado civil:

Casada ()

Conviviente ()

Soltera ()

Cuestionario adaptado a SERVQUAL modificado, para evaluar percepción de la calidad de atención en planificación familiar

Califique las percepciones que se refieren a como usted **HA RECIBIDO** la atención en el consultorio de Planificación Familiar. Utilice una escala numérica del 1 al 7. Considere a 1 como la menos calificación y 7 como la mayor calificación.

N	PERCEPCION DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN	1	2	3	4	5	6	7
	FIABILIDAD							
1	¿Recibió orientación adecuada para llegar al consultorio de planificación familiar?							
2	¿Recibió atención de planificación familiar en el horario programado?							
3	¿Se respetó el orden de llegada para recibir la atención en planificación familiar?							
4	¿Su historia clínica estuvo fácilmente para recibir la atención por planificación familiar?							
5	¿Considera que el horario de atención en planificación familiar es conveniente para usted?							
	CAPACIDAD DE RESPUESTA							
6	¿El tiempo de espera para la atención en planificación familiar fue adecuado?							
7	¿El profesional de salud encargado de planificación familiar se desenvolvió adecuadamente durante la atención?							
8	¿El tiempo durante la consulta en planificación familiar fue el adecuado para poder resolver sus necesidades?							
9	¿La entrega del método anticonceptivo en el consulto fue adecuado?							
	SEGURIDAD							
10	¿Tuvo privacidad durante su atención en el consultorio de planificación familiar?							
11	¿Piensa que el profesional de salud, encargado de planificación familiar, sabía cuáles eran los métodos de planificación familiar adecuados y disponibles para su atención?							
12	¿El personal de salud empleo un lenguaje apropiado, y el suficiente material para que entendieras todo lo que deseabas?							
13	¿Piensa que la conversación en consulta que tuvo con el personal de salud, fue confidencial?							
	EMPATÍA							
14	¿El personal de planificación familiar la trato con amabilidad, respeto y paciencia?							
15	¿El profesional de planificación familiar se preocupó por utilizar lenguaje comprensible en su atención?							

16	¿El profesional de planificación familiar le ofreció suficiente información sobre la elección de los métodos anticonceptivos?							
17	¿El profesional de planificación familiar repitió la información brindada en su atención, asegurando su comprensión?							
18	¿El profesional de planificación familiar le dio información correcta sobre la próxima cita?							
	ASPECTO TANGIBLES							
19	¿Hay una buena señalización y ubicación, para el fácil acceso a los consultorios de planificación familiar?							
20	¿El servicio de planificación familiar cuenta con el personal de salud apto que informe y oriente correctamente a los pacientes?							
21	¿El servicio de planificación familiar cuenta con suficientes métodos anticonceptivos necesarios para su atención?							
22	¿El consultorio de planificación familiar y la sala de espera se encontraron limpios y fueron cómodos?							

Anexo N°2: CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Fecha: / /

Se está trabajando en un estudio de investigación científica que ayudara en la elaboración de una tesis profesional de Obstetricia titulada “Calidad en la atención del servicio de planificación familiar en usuarias del Centro de Salud “Manuel Bertorini Jordan” San Miguel marzo 2024”. Por eso se le pide cortésmente que conteste unas preguntas con toda sinceridad posible, las respuestas brindadas serán estrictamente confidenciales y anónimas, no hay respuesta correcta o incorrecta, usted es libre de desistir en seguir participando en cualquier momento si siente alguna incomodidad en las preguntas. Se agradece su participación.

Yo _____ doy mi consentimiento para participar en la investigación científica titulada “Calidad en la atención del servicio de planificación familiar en usuarias del Centro de Salud “Manuel Bertorini Jordan” San Miguel marzo 2024” que es realizado por la estudiante de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad San Martín de Porres Brenda del Rosario Ramírez Rojas, se me ha explicado el procedimiento a seguir y que mi participación es enteramente voluntaria y será estrictamente confidencial y anónima. Al firmar el presente documento autorizo que se me incluya en esta investigación científica.

Firma del participante

Firma del investigador

Anexo N° 3: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

TABLA N°1: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO (Alfa de Cronbach)

N	ITEM																						Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	1	2	2	4	5	1	5	4	3	3	3	5	3	5	5	3	3	5	3	3	3	3	74
2	7	6	7	7	6	5	7	7	7	7	7	7	6	4	6	6	6	4	6	6	4	7	135
3	7	7	6	4	6	2	7	7	4	5	6	6	2	6	7	7	6	7	6	7	7	7	129
4	1	2	1	3	4	4	2	5	6	6	4	6	3	6	6	7	7	5	6	6	7	7	104
5	2	3	4	4	2	2	3	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	78
6	5	6	5	5	6	5	6	5	6	4	5	5	5	6	6	5	5	4	5	5	6	6	116
7	5	5	3	2	3	4	6	6	6	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	5	113
8	3	4	6	6	5	6	6	6	1	5	5	4	5	5	5	4	5	6	2	5	3	3	100
9	4	4	3	4	5	2	4	5	1	5	5	5	4	6	6	6	6	5	3	4	4	5	96
10	1	1	4	3	7	1	5	1	7	1	5	3	7	1	1	1	2	5	1	4	7	2	70
11	1	4	6	5	3	3	2	3	2	1	5	3	2	2	3	4	2	2	3	3	3	4	66
12	2	2	3	3	4	4	5	4	4	3	6	3	3	3	3	3	3	6	2	3	2	4	75
13	4	3	5	5	3	4	6	5	6	4	6	4	5	5	6	6	5	4	3	5	2	4	100
14	1	2	5	5	3	2	4	4	2	1	3	2	1	6	5	5	2	7	2	4	4	4	74
15	4	5	5	5	7	3	5	3	6	1	5	5	2	6	6	5	5	6	2	3	4	4	97
Varianza	4.60	3.21	2.81	1.67	2.54	2.31	2.55	2.70	4.54	3.81	1.21	1.98	3.12	2.64	2.57	2.74	2.84	1.78	3.11	1.84	3.03	2.40	478.12
Suma_var	60.01																						

r-Alpha de Cronbach	0.92
---------------------	------

VALIDEZ DE CONTENIDO: PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS

CRITERIOS	Nº de Jueces						Prob.
	1	2	3	4	5	6	
1. El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación.	1	1	1	1	1	1	0.031
2. El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio.	1	1	1	1	1	1	0.031
3. La estructura del instrumento es adecuado	1	1	0	1	1	1	0.219
4. Los ítems (preguntas) del instrumento están correctamente formuladas. (claros y entendibles)	1	0	1	1	1	1	0.219
5. Los ítems (preguntas) del instrumento responden a la Operacionalización de la variable	1	1	1	1	1	1	0.031
6. La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento	1	1	1	1	1	1	0.031
7. Las categorías de cada pregunta (variables) son suficientes.	1	0	0	1	1	1	0.688
8. El número de ítems (preguntas) es adecuado para su aplicación	1	1	1	1	1	1	0.031

Para la calificación de los puntajes se ha considerado:

- Favorable = 1 (SI)
- Desfavorable = 0 (NO)

Al aplicar la prueba binomial para verificar la validez de contenido de acuerdo al juicio de expertos, se tiene como resultado que existe evidencias estadísticas para afirmar que hay concordancia favorable entre los seis jueces expertos respecto a la validez del instrumento ($p < 0.05$). Los criterios: 1, 2, 5, 6 y 8 tienen un $p < 0.05$, por lo tanto, sí existe concordancia en estos ítems.

Sin embargo, respecto a los criterios 3, 4 y 7, el instrumento fue revisado para cumplir con la formulación correcta de los ítems, con la estructura y con la suficiencia de categorías, tomándose en consideración lo sugerido por los expertos.

PUNTAJES DE LA PERCEPCION DE CALIDAD SEGÚN LA ESCALA DE ESTANONES.

Estadísticos

CALIDAD DE ATENCION		
N	Válidos	30
	Perdidos	0
Media		96.73
Desv. típ.		12.38

A	106.021674
B	87.4449925

BUENO	mayor a 106
REGULAR	87 a 106
MALO	menor a 87

Estadísticos

FIABILIDAD		
N	Válidos	30
	Perdidos	0
Media		22.1000
Desv. típ.		3.90711

A	25.0303333
B	19.1696667

BUENO	mayor a 25
REGULAR	19 a 25
MALO	menor a 19

Estadísticos

CAPACIDAD DE RESPUESTA		
N	Válidos	30
	Perdidos	0
Media		17.4000
Desv. típ.		3.98791

A	20.3909346
B	14.4090654

BUENO	mayor a 20
REGULAR	14 a 20
MALO	menor a 14

Estadísticos

SEGURIDAD		
N	Válidos	30
	Perdidos	1
Media		17.4000
Desv. típ.		4.00517

A	20.4038768
B	14.3961232

BUENO	mayor a 20
REGULAR	14 a 20
MALO	menor a 14

Estadísticos

EMPATÍA		
N	Válidos	30
	Perdidos	0
Media		21.8667
Desv. típ.		3.47139

A	24.470212
B	19.2631213

BUENO	mayor a 24
REGULAR	19 a 24
MALO	menor a 19

Estadísticos

ASPECTOS TANGIBLES		
N	Válidos	30
	Perdidos	0
Media		17.9667
Desv. típ.		2.85854

A	20.1105734
B	15.8227599

BUENO	mayor a 20
REGULAR	15 a 20
MALO	menor a 15